

Fecha Última Actualización: 17-04-2023 19:05:58

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Marco Héctor Maloy Zúñiga
Edad : 74a 9m 16d
Dirección : Alonso Escobar 3610

Rut : 5.438.192-1
Fecha Nacto: 01/07/1948
Comuna : La Pintana

N° Archivo : A385989
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 4743 3731

N° Epicrisis
349862

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 20/02/2023 17:47

Días Estadía: 56

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 17/04/2023 14:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

HTA; LCFA sospecha EPOC tabáquico (no tiene PFP); Cardiópata coronario (3DES 2012);

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

FI CASR: 20/02/23
FI UPC: 20/02/23
FI UTIM: 29/03/23
FI SALA: 11/04/23

ANTECEDENTES:

Médicos:HTA, LCFA sospecha EPOC tabáquico (no tiene PFP), cardiópata coronario (3DES 2012).

Quirúrgicos: desconocidos

Alergias: (-)

Hábitos: Tabaquismo activo, OH social, Drogas (-)

Social: Vive solo, independiente para ABVD.

HISTORIA DE INGRESO:

Paciente con antecedentes descritos, acude al servicio de urgencias del HPH por dolor lumbar de cuatro días de evolución. En ese contexto, se realiza imagen de abdomen en donde se pesquisa aneurisma abdominal infrarrenal roto, por lo que se deriva al servicio de urgencia de esta institución para resolución por cirugía vascular.

A su ingreso se presenta estable hemodinámicamente, vigil, consciente y lúcido, abdomen distendido, pulsos femorales presentes, distales disminuidos, no se palpan pedios bilaterales, se realiza laboratorio en el que destaca: creatinina 1.27, LDH 185, PCR 246, INR 1.17, hematocrito 28.0, leucocitos 11.880, plaquetas 176.000, Ingresa a pabellón de urgencia donde se realiza resolución quirúrgica de Aneurisma abdominal, con extracción de trombos ilíacos y buena hemostasia. Con salida a UPC para post operatorio inmediato.

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN

Hemodinamia: En contexto quirúrgico inicialmente con DVA que se suspende el 24/02, con posterior tendencia a la hipertensión, manejada inicialmente con BIC de nitroglicerina, luego con VDO. El 05/03 nuevamente requiere DVA en dosis bajas por con suspensión precoz el 10/03. Actualmente con HDN estable, con VDO bien tolerados.

Cardio/vascular: Ingresa por aneurisma aórtico abdominal roto que se resuelve el 20/02/23 mediante laparotomía de urgencia, extrayendo trombos frescos de ambas arterias ilíacas y se instala prótesis bifurcada con hemostasia satisfactoria. Inicialmente dificultad de retorno de pulsos distales (pedios) que mejora con volemisación, Actualmente de alta por cirugía vascular.

Fecha Epicrisis : 17/04/2023 19:05

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 17-04-2023 19:05:58

Página 2 de 3

El 02/03 cursa FA RVR que se maneja con bolo y BIC de amiodarona, volviendo a ritmo sinusal, por FA y TEP (segmentario derecho 24/02), se mantiene con anticoagulación con HBPM. Se realiza ecocardiograma TT que evidencia BFGyS, FEVI 71%, AI dilatada ligera, CVD° normales, AP normal.

Respiratorio: Con antecedente de limitación crónica al flujo aéreo Obs. EPOC, lo que dificulta inicialmente VMI en postquirúrgico inmediato requiriendo ketamina y relajó neuromuscular. En TAC de 24/02 se pesquisa TEP segmentario derecho, con contraindicación de trombolisis, pero cirugía vascular da pase para anticoagulación. Cursa con weaning dificultoso por mala mecánica ventilatoria y bastante retención de CO2 asociada a obstrucción bronquial que se maneja con corticoides, BD, KNT y finalmente se realiza TQT percutánea el 14/03.

El 29/03 logra 48 horas de ventilación espontánea, con buena tolerancia a la sedestación y PaFi aceptables (250). Dado buena evolución clínica se realiza decanulación 10/04. Por posible EPOC se indica BD y LABA, actualmente no obstruido y sin requerimientos de oxígeno, evaluado por equipo de broncopulmonar, en plan de continuar con controles de forma ambulatoria.

Infeccioso: Se inicia Ampicilina-Sulbactam empíricamente al ingreso por sospecha de EPOC exacerbado. CAET del 22/02 positivo para Proteus Mirabilis por lo que se mantiene completando 7 días. El 06/03 nuevo CAET (+) para mismo microorganismo y el 08/03 positivo para Klebsiella Pneumoniae multisensible que inicialmente se maneja con meropenem, pero ante sensibilidad se pasa a Ceftriaxona completando en total 16 días de terapia antibiótica, suspendiéndose sin recaídas del punto de vista infeccioso. Actualmente afebril.

Renal/Medio Interno: Al ingreso AKI KDIGO I de origen probable pre-renal por hipovolemia, que mejora con volemización hasta normalizar. Cursa durante estadía en UPC con hipernatremia severa manejada satisfactoriamente con agua libre y volemización endovenosa. Actualmente sin conflicto.

ETE El 24/02 se pesquisa TEP agudo segmentario en LM derecho con contraindicación de trombolisis. Se inicia, previo evaluación cirugía vascular, anticoagulación con HNF y luego HBPM. 6/03 TAC de tórax muestra resolución de TEP en lóbulo medio.

Rehabilitación: Paciente crítico crónico, actualmente en rehabilitación multimodal. En seguimiento por nutrición, fonoaudiología y kinesiología.

·Motor: Tolera bipedestación asistido y marcha estática. Sedente borde cama con asistencia moderada.

·FNA: disfagia leve en seguimiento, se indica retiro de SNG (11/04) y se autoriza régimen BSG + liq claros.

Social: Evaluado por asistente social el día 10/04. Se conversa con hija (Denisse Maloy Figueroa) quien se encargará de los cuidados domiciliarios del paciente al alta. Dado paciente con domicilio en La Pintana, se solicita UHD en HPH.

LABORATORIO RECIENTE

11/04 Hb 11.9 Hto 36.4 GB 7510 RAN 4500 PQT 272 ELP 139/3.99/107 Crea 0.77 BUN 26.5 Ca 9 P 3.6 Mg 2.2 pH 7.44 HCO3 23.2

08/04 Hb 11.9 Hto 35.6 GB 6070 RAN 4000 PQT 240 ELP 141/3.83/108 Crea 0.73 BUN 26.5 LDH 164 PCR 64.2

DIAGNÓSTICOS DE TRASLADO

1) Aneurisma de aorta abdominal roto con hematoma retroperitoneal, 20/02/23 se realiza laparotomía de urgencia y se instala prótesis aórtica

2) Falla multiorgánica 2° shock hipovolémico, recuperada

3) Falla hemodinámica, ventilatoria, renal, compromiso de conciencia, coagulopatía.

·Insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica

·LCFA sospecha EPOC, descompensado

·Crisis obstructiva severa, hipoxemia severa con necesidad de relajación neuromuscular

·Atelectasia completa de LII

4) TEP agudo segmentario derecho anticoagulado (Dg 24/02)

5) VMI prolongada ¿ TQT PCT 14/3 - Decanulado 10/4

6) NAVM por P mirabilis y K. pneumoniae MS, tratadas.

7) FA con RVR resuelta en anticoagulación (CHADS - VASC 3 puntos)

8) Antecedentes patológicos personales: IAM CSDST (3 STENT ¿ 2012), tabaquismo activo, limitación

Fecha Epicrisis : 17/04/2023 19:05

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:57

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 17-04-2023 19:05:58

Página 3 de 3

crónica del flujo aéreo / EPOC, HTA

Diagnóstico de Egreso

insuficiencia respiratoria resuelta -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en buenas condiciones generales, hemodinámicamente estable, normotenso, normocárdico, afebril y sin requerimientos de oxígeno suplementario. Dado resolución de patologías agudas, paciente en condiciones de alta a domicilio con hospitalización domiciliaria para continuar rehabilitación con kinesioterapia motora y para traslape de anticoagulación de enoxaparina a anticoagulantes orales (TACO, eventualmente Rivaroxaban según compra familiar).

Plan Post Alta

1) Derivación a UHD para KNT motora y para traslape de HBPM a TACO.

2) Indicaciones generales:

- Reposo relativo, activar
- Régimen bajo en sodio, diabético
- Asistir a control con cardiología post alta dado aneurisma abdominal.
- Asistir a control con broncopulmonar dado antecedente de EPOC.
- Mantener control en poli de TACO, ajuste de terapia según exámenes. Evaluar cambio por Rivaroxaban (según compra de familiar).

3) Medicamentos:

- Amlodipino 5 mg al día por VO
- Bisoprolol 1,25 mg al día por VO
- Berodual 4 puff cada 6 horas por AEC
- Salmeterol 2 puff cada 12 hrs por AEC
- Quetiapina 12.5 mg en la noche por VO.
- Lactulosa 30 ml cada 12 horas por VO.
- Paracetamol 1gr cada 8 horas por VO
- Omeprazol 20 mg al día VO.
- Enoxaparina 80 mg cada 12 horas SC.
- Acenocumarol según esquema

Se cierra epicrisis en mi condición de coordinador de turno, no equipo tratante

Indicaciones

Tipo de Reposo :

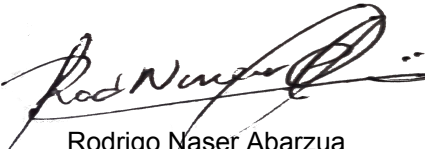
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Rodrigo Naser Abarzua
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 17/04/2023 19:05

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:57

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar